

यह मूत्राशय की गर्दन पर बने कड़े निशान की मरम्मत है — पूरी तरह scope के ज़रिए, बिना किसी बाहरी चीरे के। सर्जन निशान को खोलते हैं, फिर मूत्राशय की स्वस्थ परत को उसके ऊपर टाँकते हैं, ताकि वह जगह खुली रहकर ठीक हो।

इस प्रक्रिया के बारे में

प्रोस्टेट सर्जरी या radiation के बाद **मूत्राशय की गर्दन** (bladder neck) पर एक कड़ा निशान बन सकता है जो पेशाब की धार को रोकता है। केवल निशान काटने से वह फिर बंद हो जाता है।

यह तकनीक — **TUITMR** (transurethral incision with transverse mucosal realignment) — इस समस्या को हल करती है:

- सर्जन scope के ज़रिए **निशान को काटते** हैं ताकि रास्ता खुले।
- फिर एक विशेष **suturing tool** से मूत्राशय की स्वस्थ परत को ऊपर लाकर कटी जगह पर टाँका जाता है।

शुरुआती नतीजे उत्साहजनक हैं: **10 में से लगभग 9** मरीज़ों में एक ही प्रक्रिया के बाद रास्ता खुला रहता है, और लगभग सभी दूसरी बार के बाद — नई leakage का जोखिम बहुत कम है।

क्या यह सुरक्षित है?

यह पूरी तरह मूत्रमार्ग के ज़रिए होती है — बड़े robotic या open ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। नई मूत्र leakage का जोखिम कम है। संभावित जोखिमों में रक्तस्राव, UTI, और निशान का फिर बनना शामिल हैं। यह एक नई, विशेष तकनीक है।

शब्दों को समझें

Bladder neck

मूत्राशय का निकास जो मूत्रमार्ग में खुलता है।

Bladder neck contracture

bladder neck पर कड़ा निशान जो पेशाब की धार रोकता है।

Anastomotic stenosis

प्रोस्टेट सर्जरी के बाद जोड़ पर बना निशान।

मूत्रमार्ग

वह नली जो शरीर से पेशाब बाहर ले जाती है।

Mucosa (परत)

निशान को ढकने के लिए लाई गई स्वस्थ भीतरी परत।

Cystoscope

वह पतला camera जिससे सर्जन काम करते हैं।

मूत्र असंयम

पेशाब का रिसना — यह तकनीक इसे कम रखती है।

Catheter

ठीक होने के दौरान मूत्रमार्ग में रखी नरम नली।

क्या इसमें दर्द होगा? प्रक्रिया एनेस्थीसिया में होती है, इसलिए दौरान कुछ महसूस नहीं होता। बाद में कुछ दिन हल्की जलन और हल्का गुलाबी पेशाब हो सकता है। Catheter थोड़े समय के लिए रहता है। अधिकतर मरीज़ उसी दिन या थोड़े समय बाद घर जाते हैं।

तैयारी कैसे करें (प्रक्रिया से पहले)

- **जनरल एनेस्थीसिया** दिया जाता है — सभी सर्जरी निर्देश मानें (खाली पेट रहना, blood thinner सहित कौन सी दवाएँ रोकनी हैं)।
- संक्रमण जाँचने के लिए **पेशाब का test** होता है — संक्रमण हो तो पहले उपचार ज़रूरी है।
- थोड़े समय के लिए **catheter** की व्यवस्था रखें और घर जाने की सवारी तय करें।

अपनी टीम को पहले बताएँ यदि आप:

- **blood thinner** लेते हैं, या अभी पेशाब में संक्रमण है
- **प्रोस्टेट सर्जरी, radiation**, या इस जगह पहले कोई उपचार हुआ हो

प्रक्रिया के दौरान क्या होता है

- 1 आप एनेस्थीसिया में होते हैं और antibiotics दिए जाते हैं।
- 2 Scope को निशान तक पहुँचाया जाता है और सुरक्षा के लिए guidewire डाली जाती है।
- 3 निशान को चौड़ा और काटकर रास्ता खोला जाता है।
- 4 मूत्रमार्ग से डाले गए suturing tool से स्वस्थ परत को आगे लाकर टाँका जाता है और catheter रखा जाता है।

बाद में

- **उसी दिन या थोड़े समय बाद** घर जाते हैं; catheter कुछ समय रहता है।
- कुछ दिन **हल्की जलन और गुलाबी पेशाब** सामान्य है। अधिक पानी पीएँ।
- कुछ हफ्तों तक **भारी सामान उठाने और ज़ोर लगाने से बचें**।
- लगभग **4 महीने** बाद scope से जाँच होगी कि रास्ता खुला है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार या ठंड लगना
- **पेशाब न हो पाना**, खासकर catheter निकलने के बाद
- नई भारी मूत्र **leakage**
- भारी रक्तस्राव, blood clots, या बढ़ता दर्द

याद रखने योग्य तीन बातें

1. यह बिना चीरे की मरम्मत है — निशान खोलकर स्वस्थ परत से ढका जाता है, नई leakage का जोखिम कम है।
2. तैयारी: खाली पेट व दवा के निर्देश मानें, संक्रमण पहले ठीक करें, catheter और सवारी की व्यवस्था रखें।
3. कुछ दिन हल्की जलन और गुलाबी पेशाब सामान्य है; बुखार, पेशाब न होना, भारी leakage या रक्तस्राव पर तुरंत फोन करें।